

Arzt-Patient-Gespräch – Simulation

Patient: Herr Gotthilf Weindele | 54 Jahre | Verdacht: Depressive Episode

■ Arzt fragt

■ Patient antwortet

■ Klinische Notiz

■ Eröffnung des Gesprächs

■ Guten Tag, Herr Weindele. Ich bin Dr. [Name]. Was führt Sie heute zu uns?

■ Ja... guten Tag. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es geht mir einfach nicht gut. Seit meine Tochter gestorben ist – das ist jetzt etwa zwei Monate her – bin ich irgendwie... nicht mehr ich selbst. Mein Bruder hat gesagt, ich soll endlich zum Arzt gehen.

■ 1. Aktuelle Beschwerden (Abschnitt 2 im Bogen)

■ Seit wann genau geht es Ihnen nicht gut?

■ Seit ungefähr zwei Monaten. Genau seit dem Tod meiner Tochter.

■ Was fühlen Sie – können Sie das beschreiben?

■ Ich bin die ganze Zeit traurig. Und so leer innen drin. Früher hab ich gerne Fußball geschaut, bin manchmal rausgegangen – jetzt ist mir alles egal. Nichts macht mir mehr Spaß. Gar nichts.

■ Anhedonie + depressive Verstimmung

■ Wie ist das mit Ihrer Energie und Müdigkeit?

■ Ich bin ständig kaputt – dabei mach ich ja kaum etwas. Morgens ist es am schlimmsten. Ich lieg im Bett und kann mich einfach nicht hochraffen. Das dauert manchmal bis Mittag. Abends geht es ein bisschen besser.

■ Fatigue + Morgen-Tief – klassisches Depressionsmuster!

■ Haben Sie Kopfschmerzen oder andere körperliche Schmerzen?

■ Ja, ich hab oft Kopfschmerzen – so ein dumpfer Druck, auf beiden Seiten. Und der ganze Körper tut mir weh: die Muskeln, die Gelenke. Ich fühl mich wie ein alter Mann.

■ Cephalgie (beidseitig, drückartig) + Myalgien + Arthralgien

■ Wie ist Ihr Schlaf?

■ Schlecht. Ich wach nachts immer wieder auf – manchmal zwei, dreimal. Und dann lieg ich da und komm einfach nicht mehr rein. Morgens bin ich genauso müde wie abends.

■ Insomnie mit Durchschlafstörung

■ Wie ist Ihr Appetit? Haben Sie Gewichtsveränderungen bemerkt?

■ Ich mag eigentlich kaum noch essen. Aber komischerweise hab ich trotzdem zugenommen – ich versteh das selbst nicht.

■ Inappetenz + paradoxe Gewichtszunahme (+10 kg in 2 Monaten)

■ Fühlen Sie sich nervös oder unruhig?

■ Ja, ich bin innerlich so unruhig. Nervös. Ich kann mich auf nichts konzentrieren – nicht mal auf einen kurzen Text oder die Nachrichten.

■ ■ *Agitiertheit + Konzentrationsstörung*

■ **Sie haben kurz gesagt, manchmal fühlt sich alles sinnlos an – was meinen Sie damit genau?**

■ Ja... manchmal denk ich, wozu das alles noch. Ob es Sinn macht weiterzumachen.

■ ■ *Red Flag! Suizidalität vorsichtig weiter explorieren!*

■ **Haben Sie konkrete Gedanken daran, sich etwas anzutun oder sich das Leben zu nehmen?**

■ Ich hab keine konkreten Pläne oder so. Es ist mehr so ein Gedanke, der manchmal kommt und wieder geht.

■ ■ *Passive Suizidgedanken – keine konkrete Planung. Immer dokumentieren!*

■ **Haben Sie neurologische Beschwerden – Taubheit, Lähmungen, Sehstörungen?**

■ Nein, sowas habe ich nicht.

■ 2. Vegetative Anamnese (Abschnitt 3 im Bogen)

■ **Hatten Sie in letzter Zeit Fieber?**

■ Nein, kein Fieber.

■ **Nachtschweiß – schwitzen Sie nachts stark?**

■ Nein, das auch nicht.

■ **Übelkeit oder Erbrechen?**

■ Nein.

■ **Haben Sie Schwindel?**

■ Ja, gelegentlich – aber nicht oft.

■ **Atemnot oder Husten?**

■ Nein, das nicht.

■ 3. Vorerkrankungen / Operationen / Medikamente (Abschnitt 4)

■ **Haben Sie Vorerkrankungen – also Krankheiten, die schon länger bestehen?**

■ Ja. Ich hab Bluthochdruck, das ist seit ungefähr fünf Jahren so. Und meine Gelenke machen Probleme – Arthrose hat der Arzt damals gesagt.

■ ■ *Arterielle Hypertonie + Arthrose*

■ **Waren Sie schon mal operiert?**

■ Ja, einmal als Kind – der Blinddarm musste raus. Und vor zwei Jahren die Prostata. Das war nicht einfach.

■ ■ *Appendektomie (Kindesalter) + Prostatektomie (vor 2 Jahren)*

■ **Welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig?**

■ Für den Bluthochdruck nehm ich zwei Tabletten – Ramipril und noch eine, ich glaub HCT heißt die. Und abends nehm ich manchmal Diazepam, sonst schlaf ich gar nicht. Bei Gelenkschmerzen nehm ich Ibuprofen oder Paracetamol.

■ ■ *Ramipril 10mg + HCT 12,5mg + Diazepam (Vorsicht: Abhängigkeit!) + Ibuprofen/Paracetamol bei Bedarf*

■ 4. Allergien / Unverträglichkeiten (Abschnitt 5)

■ Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten?

■ Ja, im Frühling – Heuschnupfen. Die Augen tränen dann immer. Und Tomaten vertragen ich nicht, da bekomme ich Magenprobleme.

■ ■ *Pollenallergie (Konjunktivitis) + Tomatenunverträglichkeit (Magenbeschwerden)*

■ 5. Noxen / Genussmittel (Abschnitt 6)

■ Rauchen Sie?

■ Ja... leider. Seit zwanzig Jahren. Eine Schachtel am Tag, ungefähr.

■ ■ *20 Packyears (PY) – relevanter Nikotinabusus*

■ Trinken Sie Alkohol?

■ Ja, ich trinke schon ein bisschen. Seit meine Tochter gestorben ist, ist es mehr geworden. Hilft mir irgendwie, abends runterzukommen.

■ ■ *Erstmal vage Antwort – unbedingt nachhaken!*

■ Wie viel ungefähr – können Sie das schätzen?

■ Naja... sechs, manchmal acht Bier am Tag. Ich weiß, das ist zu viel.

■ ■ ■ *ACHTUNG: 6–8 Bier/Tag = schwerer Alkoholabusus! Alkoholabhängigkeit als Differentialdiagnose und Risikofaktor!*

■ Nehmen Sie Drogen – Cannabis oder andere Substanzen?

■ Nein, sowas nicht.

■ Treiben Sie Sport oder sind Sie körperlich aktiv?

■ Früher schon. Jetzt... nein. Ich komme ja kaum aus dem Haus.

■ ■ *Kein Sport – Bewegungsarmut verstärkt Depression*

■ 6. Familienanamnese (Abschnitt 7)

■ Gibt es in Ihrer Familie psychische Erkrankungen oder schwere Krankheiten?

■ Meine Mutter hatte auch Depressionen. Und Bluthochdruck. Und mein Vater... der hat sich das Leben genommen. Mit 58 Jahren. Das war schwer für uns alle.

■ ■ *Genetische Belastung: Depression (Mutter) + Suizid (Vater) – erhöhtes Suizidrisiko!*

■ Haben Sie Geschwister – und wie geht es denen?

■ Ich hatte eine Schwester. Die ist erst kürzlich gestorben – Blutkrebs. Es ist gerade alles sehr viel auf einmal.

■ ■ *Schwester kürzlich an Leukämie verstorben – mehrfacher Verlust in kurzer Zeit!*

■ 7. Sozialanamnese (Abschnitt 9)

■ **Was machen Sie beruflich?**

■ Im Moment gar nichts – ich bin arbeitslos. Früher war ich Verkäufer. Das hat mir eigentlich Spaß gemacht.

■ **Arbeitslosigkeit = zusätzlicher psychosozialer Stressor**

■ **Sind Sie verheiratet – haben Sie Familie?**

■ Ich bin geschieden. Meine zwei Töchter sind erwachsen und gesund – Gott sei Dank. Die machen sich gerade Sorgen um mich.

■ **Wie wohnen Sie – leben Sie alleine?**

■ Ja, ich lebe alleine.

■ **Soziale Isolation – wichtiger Risikofaktor!**

■ Abschluss des Gesprächs

■ **Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten – etwas, das ich noch nicht gefragt habe?**

■ Ich weiß nicht... ich bin einfach so müde von allem. Ich will nicht mehr so weiterleben wie jetzt. Ich hoffe, Sie können mir irgendwie helfen.

■ Klinische Zusammenfassung

Verdachtsdiagnose: Depressive Episode (mittelgradig bis schwer) nach ICD-10

Haupttrisikofaktoren: Suizid des Vaters · Alkoholabusus (6–8 Bier/Tag) · Soziale Isolation · Arbeitslosigkeit · Mehrfachverlust (Tochter + Schwester)

Wichtigste Differentialdiagnosen: Hypothyreose · Alkoholabhängigkeit · Somatisierungsstörung

Nächste Schritte: Suizidalität engmaschig monitorieren · Labor (TSH, Leberwerte, Blutbild) · Psychotherapie + SSRI erwägen · Alkoholreduktion besprechen